BONUS 1

Bank met 200 conclusiezinnen

200 kant-en-klare zinnen voor Conclusie / Indruk, geordend per modaliteit en systeem, voor normale onderzoeken, incidentele bevindingen en spoedbevindingen. Sluit je verslag af met één heldere zin waarmee de lezer weet wat hij moet doen.

Inhoud

Hoe schrijf je een conclusiezin

Röntgenfoto — 50 zinnen

CT — 70 zinnen

MRI — 35 zinnen

Echografie / Doppler — 45 zinnen

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe schrijf je een conclusiezin

Stap SAMENVATTEN: antwoord op de klinische vraag, belangrijkste bevinding eerst, zo nodig aanbeveling en melding.

> *De meeste clinici lezen eerst de Conclusie. Hoe goed de bevindingen ook zijn: als de Conclusie vaag is, blijft het verslag onvolledig.*

1. **Beantwoord eerst de klinische vraag** — als de vraag «appendicitis?» was, moet de eerste zin zeggen of er wel of geen appendicitis is.
2. **Rangschik op belangrijkheid** — een kritieke bevinding altijd als eerste; incidentele bevindingen helemaal aan het eind.
3. **Herhaal de bevindingen niet, interpreteer ze** — De Conclusie is geen kopie van de Bevindingen, maar hun betekenis.
4. **Formuleer de aanbeveling specifiek** — in plaats van «aanvullend onderzoek aanbevolen»: welk onderzoek en waarom.
5. **Leg bij een spoedbevinding de melding vast** — aan wie, hoe laat en via welke weg het is gemeld.

Soorten zinnen

LABEL	WANNEER	IN DEZE BANK
NORMAAL	Geen pathologie of geen verandering; beperkingen van de beoordeling.	43 zinnen
BEVINDING	Routinebevindingen die verband houden met de klinische vraag.	82 zinnen
INCIDENTELE	Toevalsbevinding; met een advies voor algemene correlatie of follow-up.	26 zinnen
SPOED	Bevinding die direct gemeld moet worden; met vastlegging van de melding.	49 zinnen

Over follow-upintervallen

In de zinnen voor incidentele bevindingen staan geen follow-upintervallen of groottedrempels. De follow-up van noduli, bijnierlaesies, cysten en vergelijkbare bevindingen hangt af van het risicoprofiel van de patiënt en de actuele richtlijn die je instelling hanteert; zet geen getal in het verslag waar je niet zeker van bent, vraag het je supervisor.

Vierkante haken

[rechts/links], [.. mm], [uur] vul velden zoals deze in en verwijder opties die niet van toepassing zijn. Er mogen geen vierkante haken in het verslag achterblijven.

DEEL 1

Röntgenfoto

50 conclusiezinnen, per systeem.

Röntgenfoto · Thorax

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
001	Geen acute cardiopulmonale pathologie op de thoraxfoto.	NORMAAL
002	Vergeleken met het vorige onderzoek geen duidelijke verandering.	NORMAAL
003	Geen nieuwe opaciteit, effusie of pneumothorax gezien op de bedfoto.	NORMAAL
004	Tubes en katheters in de juiste positie; geen procedure-gerelateerde complicaties gezien.	NORMAAL
005	[Rechts/Links] [kwab] consolidatie; kan in samenhang met de kliniek passen bij een pneumonie.	BEVINDING
006	Vergeleken met het vorige onderzoek [rechter onderveld] duidelijke afname van de consolidatie.	BEVINDING
007	Vergeleken met het vorige onderzoek [rechter onderveld] toename van de consolidatie; klinische correlatie aanbevolen.	BEVINDING
008	[Rechts/Links] [weinig/matig/veel] hoeveelheid pleuravocht.	BEVINDING
009	Bilateraal een kleine hoeveelheid pleuravocht en basale passieve atelectase.	BEVINDING
010	[Rechts/Links] [kwab] atelectase; zo nodig wordt CT aanbevolen met het oog op een centrale obstructieve oorzaak.	BEVINDING
011	Basale lineaire (plaatvormige) atelectase.	BEVINDING
012	Cardiomegalie (op de PA-foto).	BEVINDING
013	Door de AP-projectie is de beoordeling van de hartgrootte beperkt.	BEVINDING
014	Bevindingen passend bij longoedeem; klinische correlatie wordt aanbevolen.	BEVINDING
015	Aanwijzingen voor pulmonale veneuze congestie.	BEVINDING
016	Vergeleken met het vorige onderzoek afname van de tekenen van longoedeem.	BEVINDING
017	[Rechts/Links] long [zone]: [.. mm] massalaesie; CT thorax met contrast aanbevolen.	BEVINDING
018	[Rechts/Links] [zone] caviterende laesie; klinische correlatie en CT aanbevolen met het oog op infectieuze processen en neoplasie.	BEVINDING
019	Bilateraal diffuse millimetergrote nodulaire opaciteiten (miliair patroon); klinische en microbiologische correlatie wordt aanbevolen.	BEVINDING

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
020	Aanwijzingen voor hyperinflatie; kan passen bij COPD.	BEVINDING
021	[Rechts/Links] [..]e rib: fractuur; geen pneumothorax gezien.	BEVINDING
022	De tip van de endotracheale tube ligt ten opzichte van de carina [.. cm] erboven, in de juiste positie.	BEVINDING
023	Tip van de centraalveneuze katheter in de projectie van de vena cava superior; geen pneumothorax gezien.	BEVINDING
024	[Rechts/Links] [zone]: [.. mm] nodulaire opaciteit; klinische correlatie en zo nodig CT aanbevolen voor karakterisering.	INCIDENTELE
025	Verkalkte atheromateuze veranderingen van de aorta.	INCIDENTELE
026	[Rechts/Links] pneumothorax. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
027	[Rechts/Links] uitgebreide pneumothorax en radiologische aanwijzingen voor spanning. Kritieke bevinding; [uur] telefonisch gemeld.	SPOED
028	Tip van de endotracheale tube [rechter hoofdbronchus] in de projectie. Aan het behandelteam [uur] gemeld.	SPOED
029	Tip van de neusmaagsonde [rechter hoofdbronchus] in de projectie, niet in de juiste positie; vóór gebruik [uur] gemeld.	SPOED
030	Duidelijke verbreding van het mediastinum; bij trauma of pijn op de borst wordt spoed-CT-angiografie aanbevolen met het oog op aortapathologie. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

Röntgenfoto · Abdomen

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
031	Geen tekenen van obstructie of vrije lucht op de buikoverzichtsfoto.	NORMAAL
032	De verdeling van darmgas is normaal.	NORMAAL
033	Bevindingen passend bij dunnedarmobstructie; CT abdomen met contrast aanbevolen.	BEVINDING
034	Uitgesproken fecale lading in het colon.	BEVINDING
035	[Rechts/Links] [lokalisatie] in de projectie densiteit mogelijk passend bij een radio-opake steen; correlatie met echografie of CT zonder contrast aanbevolen.	BEVINDING
036	Verkalkte densiteiten in het bekken die kunnen passen bij flebolieten.	INCIDENTELE
037	Vrije lucht onder het diafragma (pneumoperitoneum). Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
038	Bevindingen passend bij sigmoïdvolvulus. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED

Röntgenfoto · Musculoskeletaal

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
039	[Rechts/Links] [regio] geen acute botpathologie vastgesteld.	NORMAAL
040	Geen fractuur of luxatie gezien; de gewrichtsspleten zijn behouden.	NORMAAL
041	Geen fractuurlijn gezien; bij aanhoudende klinische verdenking kan een occulte fractuur op de röntgenfoto niet worden uitgesloten.	NORMAAL
042	[Rechts/Links] distale radiusfractuur ([intra-articulair/extra-articulair], [dorsaal] met angulatie).	BEVINDING
043	[Rechts/Links] scafoïd [taille] fractuur.	BEVINDING
044	[Rechts/Links] [anterieur] glenohumerale luxatie; controlefoto na repositie aanbevolen.	BEVINDING
045	[Rechts/Links] [laterale malleolus] fractuur; malleolaire vork [behouden/verwijd].	BEVINDING
046	Stand van de fractuurfragmenten na repositie [acceptabel/verstoord].	BEVINDING
047	[Rechts/Links] degeneratieve veranderingen van de knie (artrose); geen acute botpathologie.	BEVINDING
048	Posterior fat pad sign; orthopedische beoordeling wordt aanbevolen met het oog op een occulte fractuur.	BEVINDING
049	[Bot] in [.. mm] lytische laesie; klinische correlatie en aanvullend onderzoek aanbevolen voor karakterisering.	INCIDENTELE
050	[Rechts/Links] femurhalsfractuur ([gedisloceerd/niet-gedisloceerd]). Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED

DEEL 2

CT

70 conclusiezinnen, per systeem.

CT · Neuroradiologie

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
051	Geen acute intracraniële pathologie vastgesteld op blanco CT van de hersenen.	NORMAAL
052	Geen intracraniële bloeding, massa-effect of midline shift.	NORMAAL
053	Een vroeg ischemisch CVA is op blanco CT mogelijk niet zichtbaar; bij aanhoudende klinische verdenking kan een MRI-DWI worden overwogen.	NORMAAL
054	Vergeleken met het vorige onderzoek geen nieuwe bloeding of toename van het massa-effect.	NORMAAL
055	Bij de leeftijd passende cerebrale atrofie; geen acute pathologie vastgesteld.	NORMAAL
056	Periventriculaire hypodensiteiten die kunnen passen bij chronische smallvesseldisease.	BEVINDING
057	[Rechts/Links] [lokalisatie] gebied van encefalomalacie passend bij een chronisch infarct.	BEVINDING
058	[Rechts/Links] [kwab] massalaesie en vasogeen oedeem; MRI van de hersenen met contrast aanbevolen.	BEVINDING
059	[Lokalisatie] bevindingen passend bij sinusitis.	BEVINDING
060	[Rechts/Links] [bot] lineaire fractuur; geen bijkomende intracraniële bloeding.	BEVINDING
061	[Lokalisatie] extra-axiale laesie met verkalkingen; kan passen bij een meningeoom, correlatie met MRI wordt aanbevolen.	INCIDENTELE
062	[Lokalisatie] laesie met liquordensiteit die kan passen bij een arachnoïdale cyste.	INCIDENTELE
063	[Rechts/Links] acuut epiduraal hematoom; [.. mm] middenlijnverschuiving. Spoedbevinding; aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
064	[Rechts/Links] acuut subduraal hematoom; massa-effect aanwezig. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
065	Subarachnoïdale bloeding; CT-angiografie wordt aanbevolen met het oog op een aneurysma. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
066	[Rechts/Links] [lokalisatie] acuut intraparenchymateus hematoom, met doorbraak naar het ventrikelsysteem [aanwezig/afwezig]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
067	[Rechts/Links] Aanwijzingen voor vroege acute ischemie in het stroomgebied van de MCA; geen bloeding. In het kader van het CVA-protocol [uur] gemeld.	SPOED

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
068	[Rechts/Links] Hyperdense-arteriesign in de MCA; kan passen bij een acute trombus, CT-angiografie wordt aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
069	Bevindingen passend bij acute obstructieve hydrocefalus. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
070	[Subfalcine/Transtentoriële/Tonsillaire] tekenen van herniatie. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.	SPOED
071	[Rechts/Links] [bot] impressiefractuur en daaronder [extra-axiale bloeding]. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
072	Op CT-angiografie [rechts/links] [MCA M1] occlusie in het segment. In het kader van het strokeprotocol [uur] gemeld.	SPOED

CT · Thorax

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
073	Op de thorax-CT geen significante pathologie vastgesteld.	NORMAAL
074	Geen longembolie vastgesteld op CT-pulmonalisangiografie.	NORMAAL
075	Door onvoldoende opacificatie van de longarteriën is de beoordeling op subsegmentaal niveau beperkt.	NORMAAL
076	[Rechts/Links] [kwab] consolidatie; kan passen bij een infectieus proces.	BEVINDING
077	Bilaterale matglasdensiteiten; de differentiaaldiagnose omvat infectieuze en inflammatoire processen, klinische correlatie wordt aanbevolen.	BEVINDING
078	[Centrilobulair] emfyseem.	BEVINDING
079	Lymfeklieren van pathologische grootte in het mediastinum; te beoordelen in de klinische context.	BEVINDING
080	[Rechts/Links] in de long [.. mm] massalaesie en [hilair/mediastinaal] lymfadenopathie; klinische beoordeling met het oog op weefseldiagnostiek aanbevolen.	BEVINDING
081	[Rechts/Links] [kwab]: [.. mm] [solide] nodus; de noodzaak van follow-up moet op basis van het risicoprofiel en de actuele richtlijn samen met het behandelteam worden bepaald.	INCIDENTELE
082	Verkalkingen in de coronaire arteriën.	INCIDENTELE
083	Schildklier [rechts/links] hypodense nodus in de kwab; beoordeling met echografie aanbevolen.	INCIDENTELE
084	[Bilateraal] acute longembolie; aanwijzingen voor rechterventrikelbelasting [aanwezig/afwezig]. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
085	[Met/zonder betrokkenheid van de aorta ascendens] aortadissectie. Spoedbevinding; het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
086	[Rechts/Links] pneumothorax. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
087	Pneumomediastinum; bij klinische verdenking op oesofagusperforatie wordt verder onderzoek aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
088	[Matige/Grote] hoeveelheid pericardeffusie; spoedige klinische en echocardiografische beoordeling met het oog op tamponade aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

CT · Abdomen en bekken

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
089	Geen acute pathologie op CT abdomen-bekken.	NORMAAL
090	Appendix normaal van aspect; geen aanwijzingen voor acute appendicitis.	NORMAAL
091	Geen urinewegsteen of hydronefrose vastgesteld op blanco CT.	NORMAAL
092	Vergeleken met het vorige onderzoek [laesie] geen duidelijke verandering gezien.	NORMAAL
093	[Sigmoïd] acute ongecompliceerde diverticulitis van het colon.	BEVINDING
094	[Rechts/Links] [distaal] in de ureter [.. mm] steen en [licht] hydro-ureteronefrose.	BEVINDING
095	Acuut [interstitieel oedemateus] tekenen van pancreatitis.	BEVINDING
096	Bevindingen passend bij acute cholecystitis; correlatie met echografie wordt aanbevolen.	BEVINDING
097	Cholelithiasis; geen aanwijzingen voor acute cholecystitis gezien.	BEVINDING
098	Meerdere laesies in de lever die kunnen passen bij metastasen; klinische en zo nodig histopathologische correlatie wordt aanbevolen.	BEVINDING
099	Leversteatose.	BEVINDING
100	[Kleine/Matige] hoeveelheid ascites.	BEVINDING
101	[Lokalisatie] wandverdikking van het colon; de differentiaaldiagnose omvat inflammatoire, infectieuze en neoplastische oorzaken, endoscopische correlatie aanbevolen.	BEVINDING
102	Leversegment [..]: laesie passend bij een eenvoudige cyste.	INCIDENTELE
103	[Rechts/Links] laesie in de nier passend bij een eenvoudige cyste.	INCIDENTELE
104	[Rechts/Links] bijniernodule; karakterisering en follow-up moeten samen met het klinische team worden bepaald volgens de actuele richtlijn.	INCIDENTELE
105	[Rechts/Links] in de nier [.. mm] niet nader te karakteriseren laesie; voor verdere beoordeling [dynamische CT/MRI] aanbevolen.	INCIDENTELE
106	In de lever een bij dit onderzoek niet te karakteriseren [.. mm] hypodense laesie; zo nodig beoordeling met dynamische MRI aanbevolen.	INCIDENTELE
107	Bevindingen passend bij acute appendicitis. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
108	Acute appendicitis en [periappendiculair abces/perforatie] aanwijzingen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
109	Pneumoperitoneum; [mogelijke lokalisatie] passend bij perforatie. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.	SPOED
110	Overgangszone [regio] bevindingen passend bij mechanische dunnedarmobstructie en ischemie. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
111	Abdominaal aorta-aneurysma en periaortaal hematoom passend bij ruptuur. Spoedbevinding; [uur] gemeld.	SPOED
112	Miltletsel, hemoperitoneum en actieve contrastextravasatie. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
113	Pneumatosis van de darmwand en gas in de vena portae; spoedeisende klinische beoordeling wordt aanbevolen met het oog op mesenteriale ischemie. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
114	[Rechts/Links] obstructieve ureterolithiasis en [perirenale collectie/emfysemateuze verandering]; bij klinische verdenking op een geïnfecteerde obstructie wordt spoedbeoordeling aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

CT · Wervelkolom en musculoskeletaal

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
115	Geen acute traumatische ossale pathologie vastgesteld op CT van de cervicale wervelkolom.	NORMAAL
116	Ligamentair letsel kan met CT niet volledig worden uitgesloten; bij neurologische uitval wordt MRI aanbevolen.	NORMAAL
117	[L1] compressiefractuur van de wervel met acuut aspect; geen vernauwing van het wervelkanaal.	BEVINDING
118	Degeneratieve veranderingen van de lumbale wervels.	BEVINDING
119	[Wervel] sclerotische haard in het corpus; kan passen bij een boteiland, klinische correlatie aanbevolen.	INCIDENTELE
120	[Niveau] op niveau instabiel ogende fractuur/luxatie en vernauwing van het wervelkanaal. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.	SPOED

DEEL 3

MRI

35 conclusiezinnen, per systeem.

MRI · Neuroradiologie

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
121	Geen significante pathologie op MRI hersenen.	NORMAAL
122	Geen diffusierestrictie passend bij een acuut infarct op DWI.	NORMAAL
123	Na contrast geen pathologische aankleuring gezien.	NORMAAL
124	Vergeleken met het vorige onderzoek geen nieuwe of aankleurende laesies.	NORMAAL
125	Wittestofveranderingen die kunnen passen bij chronische smallvesseldisease; geen acuut infarct.	BEVINDING
126	Wittestoflaesies die kunnen passen bij een demyeliniserende aandoening; te beoordelen in samenhang met de kliniek en de actuele diagnostische criteria.	BEVINDING
127	[Regio]: extra-axiale massa passend bij een meningeoom.	BEVINDING
128	Hypofyse [micro/macro]laesie passend bij een adenoom; endocrinologische correlatie wordt aanbevolen.	BEVINDING
129	[Rechts/Links] [kwab] ringvormig aankleurende intra-axiale massa; in de differentiaaldiagnose wordt in de eerste plaats gedacht aan een hooggradige gliale tumor en metastase.	BEVINDING
130	Cysteuze laesie die kan passen bij een pijnappelkliercyste.	INCIDENTELE
131	[Lokalisatie]beeld passend bij een developmental venous anomaly (DVA).	INCIDENTELE
132	[Rechts/Links] [arterie] stroomgebied acuut infarct. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
133	Bevindingen passend bij een hersenabces. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
134	[Sinus] trombose. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED
135	Acute bloeding in een hypofyselaesie met compressie van het chiasma opticum; spoedeisende klinische beoordeling wordt aanbevolen met het oog op apoplexie. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

MRI · Wervelkolom

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
136	Op de lumbale MRI geen significante pathologie vastgesteld.	NORMAAL

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
137	Afgezien van discusdegeneratie geen aanwijzingen voor significante compressie.	NORMAAL
138	L [4-5] [rechts paramediaan] discusextrusie; [L5] compressie van de zenuwwortel.	BEVINDING
139	C [5-6] discus-osteofytcomplex en [rechts] foraminale vernauwing; geen signaalverandering in het myelum.	BEVINDING
140	[L1] in de wervel [acuut/subacuut] compressiefractuur; geen aanwijzingen voor een pathologische fractuur.	BEVINDING
141	[Wervel] laesie in het corpus passend bij een typisch hemangioom.	INCIDENTELE
142	[Niveau] op niveau laesie mogelijk passend bij epidurale tumoruitbreiding en compressie van het myelum. [Tijdstip] gemeld.	SPOED
143	[Niveau] op niveau grote discusextrusie met duidelijke compressie van de cauda-equinawortels; spoedbeoordeling in samenhang met de kliniek aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

MRI · Musculoskeletaal

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
144	[Rechts/Links] geen significante pathologie vastgesteld op de MRI van de knie.	NORMAAL
145	[Volledige dikte] VKB-ruptuur en [laterale compartiment] botkneuzingen.	BEVINDING
146	[Mediaal] meniscus [achterhoorn] [schuin] ruptuur.	BEVINDING
147	In de supraspinatuspees [volledige dikte] ruptuur; retractie [.. mm].	BEVINDING
148	[Rechts/Links] avasculaire necrose van de femurkop; geen collaps van het gewrichtsoppervlak.	BEVINDING
149	Popliteale (Baker-)cyste; geen aanwijzingen voor ruptuur.	BEVINDING
150	[Regio] beenmergbetrokkenheid in en [subperiostaal/weke delen] collectie; spoedige klinische beoordeling met het oog op osteomyelitis en abces aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

MRI · Abdomen en bekken

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
151	Geen focale laesie vastgesteld op dynamische MRI van de lever.	NORMAAL
152	Leversegment [..]: laesie passend bij een typisch hemangioom.	BEVINDING
153	Steen distaal in de ductus choledochus (choledocholithiasis) en dilatatie van de galwegen.	BEVINDING
154	[Rechts/Links] laesie in het ovarium passend bij een eenvoudige cyste; de noodzaak van follow-up moet door het behandelteam worden bepaald.	INCIDENTELE

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
155	In de pancreas [.. mm] cysteuze laesie; karakterisering en follow-up moeten volgens de actuele richtlijn samen met het behandelteam worden bepaald.	INCIDENTELE

DEEL 4

Echografie / Doppler

45 conclusiezinnen, per systeem.

Echografie / Doppler · Abdomen

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
156	Op de echo van de totale abdomen geen pathologie vastgesteld.	NORMAAL
157	Galblaas normaal; geen steen of aanwijzingen voor acute cholecystitis gezien.	NORMAAL
158	Intra- en extrahepatische galwegen niet gedilateerd.	NORMAAL
159	Geen vrij vocht in het abdomen gezien.	NORMAAL
160	Door darmgas is de beoordeling van de pancreas beperkt.	NORMAAL
161	Cholelithiasis; geen aanwijzingen voor acute cholecystitis gezien.	BEVINDING
162	Galblaasslib (sludge).	BEVINDING
163	[Licht/Matig/Uitgesproken] beeld passend bij leversteatose.	BEVINDING
164	Grove echostructuur en nodulaire contour die kunnen passen bij een chronische parenchymateuze leveraandoening.	BEVINDING
165	Splenomegalie.	BEVINDING
166	Dilatatie van de ductus choledochus; als er geen oorzaak is vastgesteld, wordt MRCP aanbevolen.	BEVINDING
167	[Weinig/Matig/Veel] hoeveelheid ascites.	BEVINDING
168	Leversegment [..]: hyperechogene laesie die kan passen bij een hemangioom; afhankelijk van de klinische context wordt verder onderzoek aanbevolen.	INCIDENTELE
169	In de galblaas [.. mm] poliep; de noodzaak van follow-up moet volgens de actuele richtlijn worden bepaald.	INCIDENTELE
170	Bevindingen passend bij acute calculeuze cholecystitis. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
171	Bevindingen passend bij acute appendicitis. Aan het klinisch team [uur] gemeld.	SPOED
172	[Ileocolisch] bevindingen passend bij invaginatie. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.	SPOED
173	Leversegment [..]: laesie die kan passen bij een abces. Aan het klinische team [uur] gemeld.	SPOED

Echografie / Doppler · Urogenitaal en bekken

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
174	Geen pathologie vastgesteld op de echografie van de urinewegen.	NORMAAL
175	Op scrotale doppler-echografie bilateraal symmetrische testiculaire doorbloeding; geen pathologie vastgesteld.	NORMAAL
176	[Rechts/Links] [licht/matig] hydronefrose; [mogelijke oorzaak].	BEVINDING
177	[Rechts/Links] in de nier [.. mm] steen; geen hydronefrose.	BEVINDING
178	[Rechts/Links] bevindingen passend bij epididymo-orchitis; testiculaire flow behouden.	BEVINDING
179	[Rechts/Links] eenvoudige corticale niercyste.	INCIDENTELE
180	Prostaat [vergroot]; klinische correlatie wordt aanbevolen.	INCIDENTELE
181	[Rechts/Links] bevindingen passend bij testistorsie. Kritieke bevinding; [uur] gemeld.	SPOED
182	Geen intra-uteriene zwangerschap gezien; samen met een adnexmassa en vrij vocht aanwijzingen voor een extra-uteriene zwangerschap. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

Echografie / Doppler · Vasculair

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
183	[Rechts/Links] geen trombose vastgesteld in de diepe venen van de onderste extremiteiten.	NORMAAL
184	Geen aanwijzingen voor hemodynamisch significante stenose in beide aa. carotides.	NORMAAL
185	[Rechts/Links] [a. carotis interna] atherosclerotische plaque in de arterie; stenosegraad volgens de criteria van de instelling [graad].	BEVINDING
186	[Rechts/Links] bevindingen passend bij oppervlakkige veneuze trombose; diep veneus systeem doorgankelijk.	BEVINDING
187	Vergeleken met het vorige onderzoek in de trombus [rekanalisatie/geen verandering].	BEVINDING
188	In de infrarenale aorta abdominalis [.. mm] verwijding; de noodzaak van follow-up moet samen met het behandelteam worden bepaald.	INCIDENTELE
189	[Rechts/Links] [femoropopliteaal] acute diepveneuze trombose in het segment. Aan het behandelteam [uur] gemeld.	SPOED
190	Bij een symptomatische patiënt [.. mm] abdominaal aorta-aneurysma; ruptuur kan met echografie niet worden uitgesloten, spoed-CT-angiografie wordt aanbevolen. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

Echografie / Doppler · Hals en oppervlakkige weefsels

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
191	Op de echo van de schildklier geen pathologie vastgesteld.	NORMAAL

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
192	Geen pathologisch ogende lymfeklieren in de hals vastgesteld.	NORMAAL
193	Schildklier [rechter kwab]: [.. mm] nodus; volgens de risicoclassificatie van je instelling [categorie].	BEVINDING
194	Heterogene echostructuur die kan passen bij een diffuse parenchymateuze schildklieraandoening; correlatie met schildklierfunctietests wordt aanbevolen.	BEVINDING
195	[Regio]: collectie passend bij een weke-delenabces en tekenen van omgevende cellulitis.	BEVINDING
196	[Rechts/Links] laesie in de mamma passend bij een eenvoudige cyste.	INCIDENTELE

Echografie / Doppler · POCUS en eFAST

NR.	CONCLUSIE / INDRUK	TYPE
197	Bij eFAST geen aanwijzingen voor vrij vocht, pericardeffusie of pneumothorax. Een negatieve eFAST sluit orgaanletsel niet uit.	NORMAAL
198	Bilateraal diffuse B-lijnen; passend bij een interstitieel syndroom.	BEVINDING
199	FAST positief: [In de ruimte van Morison] vrij vocht. Aan het behandelteam [uur] gemeld.	SPOED
200	[Rechts/Links] geen lung sliding gezien en een lung point vastgesteld; passend bij pneumothorax. [Tijdstip] gemeld.	SPOED

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Bonus 2 · De 50 verslagfouten die je supervisor het vaakst corrigeert. Je hebt geleerd de juiste conclusiezin te kiezen; leer nu de fouten herkennen waardoor een verslag wordt teruggestuurd, en maak ze niet meer.

Om de zinnen in een volledig verslag te zien **Hoofdmateriaal · 120 kant-en-klare verslagsjablonen** kun je terugkeren.